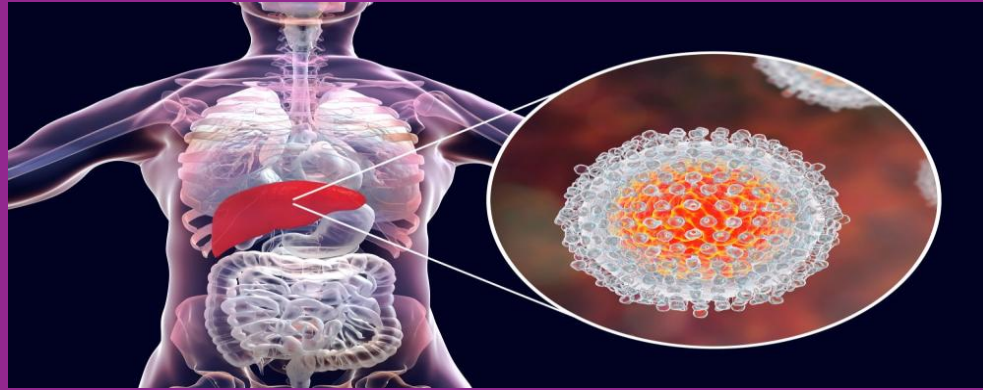




# HEPATITES VIRAIS – MANEJO NA APS

---

Iolanda Felipe da Silva Bona  
Médica de Família e Comunidade  
IESC VII



---

## OBJETIVOS:

---

1. *Compreender o acompanhamento e políticas públicas para hepatites virais.*
2. *Abordar etiologia, transmissão epidemiologia, diagnóstico, aspectos clínicos e conduta para as hepatites virais.*
3. *Conhecer diagnóstico e prevenção para as hepatites virais*
4. *Identificar os determinantes de saúde ligados a esta patologia.*

- Caracterizam-se por processos inflamatórios no fígado, de evolução aguda ou crônica e etiologias diversificadas, que resultam em alterações morfológicas, clínicas e laboratoriais, de graus variados.
- São um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.
- Segundo estimativas, bilhões de pessoas já tiveram contato com vírus das hepatites e milhões são portadores crônicos.



- Os indivíduos infectados podem ser portadores assintomáticos ou desenvolver hepatite aguda ou crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular.
- A expressão hepatite viral geralmente se refere aos vírus hepatotrópicos A, B, C, D e E, que são responsáveis por mais de 90% das hepatites agudas.
- Esses vírus têm em comum o fato de os hepatócitos lesados desencadearem respostas imunológicas e inflamatórias, porém com expressões clínicas e consequências distintas.
- Todos os casos suspeitos ou confirmados e os surtos de hepatites virais devem ser notificados e investigados, visando à proteção dos contatos não infectados.

# HEPATITE A

- O vírus da hepatite A (VHA) origina infecção aguda, contagiosa, autolimitada.
- O agente, do tipo RNA, é um pequeno vírus que pertence à família *Picornaviridae*.
- Comumente transmitida por meio de contato oral-fecal, pela ingestão de água e/ou alimentos contaminados.
- A transmissão sexual pode ocorrer com a prática sexual oral-anal; e a transmissão pelo sangue e derivados é pouco comum.



- É a mais benigna das hepatites e não evolui para formas crônicas.
- Diversos inquéritos clínico-epidemiológicos validaram o conceito de que a frequência da hepatite A está diretamente relacionada com o padrão de saneamento da região.
- É importante incentivar medidas de higiene antes e após as relações sexuais, assim como o uso de preservativos.
- Além do desenvolvimento econômico, países que incluíram programas de vacinação universal contra o VHA tiveram maior redução na incidência da doença.

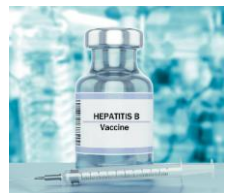


# HEPATITE B

- O vírus da hepatite B (VHB) pode ocasionar viremia transitória ou crônica e causar infecção assintomática ou sintomática, cirrose e hepatocarcinoma.
- Pertencente à família Hepadnaviridae, infecta seres humanos e algumas espécies animais (entre elas, marmotas, patos de Pequim e esquilos).
- É constituído pelo genoma (DNA circular de dupla hélice) e pela DNA-polimerase.
- A transmissão do vírus se faz pelas vias parenteral e sexual e pelo contato com sangue e/ou outros fluidos corporais contaminados.



- Contudo, a forma mais importante de transmissão, do ponto de vista epidemiológico, é a perinatal, pois é por meio dessa via que o VHB se mantém na população.
- A transmissão por transfusões de hemoderivados e transplantes de órgãos é rara.
- No Brasil, estudos realizados a partir da década de 1990 mostram mudanças importantes na endemicidade da infecção, devido principalmente à instituição, em 1998, da vacina contra o VHB.
  - ❑ Recomenda-se a vacinação para todas as pessoas, independentemente de faixa etária (três doses).
- A cronificação da hepatite B é inversamente proporcional à idade: quanto mais jovem o indivíduo ao ser contaminado, maior a probabilidade de a doença evoluir para a forma crônica.





# HEPATITE C



- O VHC é um vírus tipo RNA, que pertence à família *Flaviviridae*.
- São três as principais vias pelas quais é transmitido:
  - ❑ Parenteral (comum entre usuários de drogas ilícitas e transfundidos com hemoderivados contaminados);
  - ❑ Vertical (intraútero, intraparto ou pós-parto);
  - ❑ Mucosas (em geral quando a transmissão é sexual).
- A forma aguda da doença raras vezes é diagnosticada, pois a maioria é assintomática.
  - ❑ O diagnóstico é feito mais tarde, já em fase de cronicidade da infecção.
- É a causa mais comum de doença hepática crônica com progressão para carcinoma hepatocelular e a principal indicação de transplante hepático no mundo ocidental.

# HEPATITE D



- O vírus da hepatite D (VHD) é uma partícula incompleta constituída por RNA circular, único representante da família *Deltaviridae*.
- Depende do vírus B para o hepatotropismo e a replicação.
  - ❑ Infecta apenas os indivíduos que também apresentam positividade para o VHB.
- A transmissão do VHD pode ser simultânea com a do VHB (coinfecção), ou o VHD pode infectar os indivíduos já portadores da infecção pelo VHB (superinfecção).
  - ❑ Nas coinfeções em adultos sem imunodepressão, observam-se altas taxas de recuperação.
  - ❑ Na superinfecção, o cenário é mais sombrio: as hepatites costumam ser mais graves, com icterícia intensa, rapidamente evoluindo para insuficiência hepática.

# HEPATITE E

- O VHE pertence a família de *Hepeviridae*, gênero *Hepevirus*.
- Assemelha-se em muitos aspectos ao VHA, pois também é de transmissão entérica fecal-oral.
- Ocorre com frequência em surtos epidêmicos após calamidades que levam à contaminação da água.



| CARACTERÍSTICAS                | A                                      | B                     | C                   | D                      | E                             |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Família                        | <i>Picornaviridae</i>                  | <i>Hepadnaviridae</i> | <i>Flaviviridae</i> | <i>Deltaviridae</i>    | <i>Hepeviridae</i>            |
| Genoma                         | RNA                                    | DNA                   | RNA                 | RNA                    | RNA                           |
| Incubação (dias)               | 15 a 45                                | 30 a 180              | 15 a 150            | 30 a 180               | 15 a 45                       |
| Idade preferencial da infecção | Crianças e adolescentes                | Qualquer idade        | Qualquer idade      | Qualquer idade         | Adultos jovens                |
| Forma ictérica                 | <10% em <6 anos<br>60 a 80% em adultos | 20 a 30%              | 10 a 15%            | Variável               | Variável                      |
| Mortalidade na infecção aguda  | 0,1 a 2%                               | <1%                   | <1%                 | Alta na superinfecção  | 1 a 4%                        |
| Mortalidade na gestação        | 0,1 a 2%                               | <1%                   | <1%                 | 0,1 a 2%               | Até 20%                       |
| Cronificação                   | Não                                    | Sim                   | Sim                 | Sim                    | Raramente, em imunodeprimidos |
| Prevenção                      | Vacina                                 | Vacina                | Não                 | Vacina para hepatite B | Não                           |

Tabela 175.1 | Características clínica e epidemiológica das hepatites virais

| Agente                         | A                                    | B                                               | C                   | D                   | E                             |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Período de incubação           | 15-49 dias<br>Média = 25 dias        | 28-180 dias<br>Média = 60 dias                  | 14-160 dias         | 60-90 dias          | 15-60 dias<br>Média = 62 dias |
| Transmissão parenteral         | Não                                  | Sim                                             | Sim                 | Sim                 | Não                           |
| Transmissão fecal-oral         | Sim                                  | Não                                             | Não                 | Não                 | Sim                           |
| Transmissão vertical           | Não                                  | Sim                                             | Sim                 | Não                 | Não                           |
| Transmissão sexual             | Não                                  | Sim                                             | Rara                | Não                 | Não                           |
| Idade preferencial da infecção | Crianças e adolescentes              | Qualquer idade                                  | Qualquer idade      | Qualquer idade      | Adultos jovens                |
| Curso clínico (início)         | Agudo                                | Insidioso                                       | Insidioso           | Variável            | Agudo                         |
| Presença de icterícia          | Crianças: > 5%<br>Adultos = 30%      | 30% dos pacientes adultos                       | 5-10% dos pacientes | Muito variável      | Comum                         |
| Cronificação                   | Não existe relato de formas crônicas | 90% em neonatos e 5-10% após os 5 anos de idade | 70-85%              | Variável            | Raramente em imunodeprimidos  |
| Forma fulminante               | > 1%                                 | 0,1-0,5% dos pacientes                          | Até 0,5%            | 2-7,5% na coinfeção | < 1%                          |

# QUADRO CLÍNICO

- Varia de acordo com o tipo de vírus e as características do hospedeiro:
  - ❑ Idade e o estado imunológico são as mais importantes.
- As infecções variam desde assintomáticas até formas que evoluem para insuficiência hepática, hepatopatia crônica e carcinoma de fígado.
- Os doentes costumam apresentar manifestações inespecíficas:
  - ❑ Anorexia, náuseas, dor abdominal e lassidão ou astenia.
- Em alguns indivíduos, as queixas mais intensas são artralgias e/ou mialgias no início do quadro.
- Nas formas ictéricas das hepatites agudas, o quadro clínico costuma ser dividido em três períodos: fase prodrômica, que é anictérica, seguida pela fase com icterícia e colúria e, por fim, o período de convalescença.

# ANAMNESE

- Idade, profissão ou ocupação;
- História detalhada da doença atual;
- História de doenças hepáticas ou quadros de icterícia aguda;
- Gestação;
- Utilização de medicamentos hepatotóxicos;
- Uso de drogas com compartilhamento de materiais, drogas injetáveis (cocaína, anabolizantes e complexos vitamínicos), inaláveis (cocaína) ou pipadas (*crack*);
- Prática sexual sem preservativo;
- Transfusão de sangue ou hemoderivados antes de 1993;
- História de etilismo;
- Acidentes ocupacionais;
- Condições de saneamento básico;
- Local de procedência.



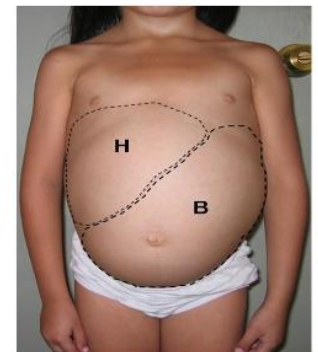
**TABELA 142.2** → Indivíduos que apresentam maior risco de adquirir hepatite viral

| PROFISSIONAIS DE SAÚDE                             |
|----------------------------------------------------|
| Enfermeiros                                        |
| Médicos                                            |
| Dentistas e cirurgiões bucofaciais                 |
| Técnicos de laboratório                            |
| POPULAÇÃO SELECIONADA                              |
| Imunodeprimidos                                    |
| Frequentadores de unidades de hemodiálise          |
| Usuários de sangue e/ou hemoderivados              |
| Homossexuais masculinos com comportamento de risco |
| Prostitutas                                        |
| Usuários de drogas injetáveis                      |
| Filhos de mães AgHBs-positivas                     |
| Salva-vidas                                        |
| Institucionalizados                                |
| Originários de zonas de alta endemicidade          |



# EXAME FÍSICO

- É necessário considerar os dados da anamnese e uma minuciosa inspeção geral e palpação abdominal.
- A icterícia é o sinal mais significativo e, em geral, o motivo da procura do atendimento médico.
- Há aumento das dimensões do fígado, cuja borda é aguda, com superfície lisa e sensibilidade aumentada à palpação e percussão.
- O baço aumenta de volume em cerca de 10 a 20% dos casos.





### Quadro 175.2 | Aspectos clínicos que podem indicar gravidade ou curso crônico das hepatites

- ▶ Hepatomegalia não dolorosa de consistência endurecida e superfície nodular
  - ▶ Eritema palmar
  - ▶ Aranhas vasculares
  - ▶ Dedos em baqueta de tambor
  - ▶ Ginecomastia
  - ▶ Presença de vômitos e/ou diarreia incoercíveis
  - ▶ Febre prolongada
  - ▶ Hálito hepático (lembra o cheiro de maçã apodrecida)
  - ▶ Ascite
- 
- ▶ Sinais de encefalopatia hepática (sonolência e/ou agitação psicomotora, *flapping* ou *asterixis* – ao estender as mãos, o paciente apresenta tremores e as mãos parecem “bater asas”)



# EXAMES COMPLEMENTARES

- Nas hepatites virais agudas de evolução benigna, observa-se linfocitose relativa, comumente associada à leucopenia no início do quadro.
- Os testes de função hepática, principalmente (AST/TGO) e (ALT/TGP), constituem as enzimas celulares que melhor representam fenômenos necróticos a que estão submetidos os hepatócitos durante a agressão pelos vírus.
  - ❑ Nas formas agudas, esses testes atingem valores até 25 vezes acima do normal.
- As bilirrubinas elevam-se após o aumento das aminotransferases e, nas formas agudas, alcançam de 20 a 25 vezes o valor normal.



- Em geral, há aumento discreto nos níveis de gama-GT.
- A atividade de protrombina sofre pouca alteração nas formas agudas e crônicas.
- Se o exame clínico orienta para o diagnóstico etiológico viral, podem-se solicitar os marcadores sorológicos.
- A avaliação e a interpretação corretas dos marcadores sorológicos virais possibilitam uma orientação adequada ao paciente, evitando exames e referenciamentos desnecessários e promovendo maior resolubilidade dos casos.





**TABELA 142.4** → Achados clínico-laboratoriais que costumam indicar maior gravidade da hepatite

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Faixa etária: recém-nascidos, lactentes e pessoas idosas |
| Desnutrição                                              |
| Gravidez                                                 |
| Indivíduos em uso de imunossupressores                   |
| Indivíduos em uso de medicação hepatotóxica              |
| Presença de edema e/ou ascite e/ou encefalopatia         |
| Presença de vômitos e/ou diarreia incoercíveis           |
| Alterações laboratoriais                                 |
| Bilirrubinemia total > 20 mg/dL                          |
| Tempo de protrombina > 50 segundos                       |
| Hipoglicemia persistente                                 |
| Hipoalbuminemia                                          |

# MARCADORES SOROLÓGICOS

## Quadro 175.4 | Avaliação dos marcadores sorológicos da hepatite A

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IgM anti-HAV | Infecção recente pelo HAV                                                |
| IgG anti-HAV | Imune à hepatite A (infecção prévia pelo HAV ou imunidade pós-vacinação) |

## Quadro 175.9 | Avaliação dos marcadores sorológicos da hepatite E

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| IgM anti-HEV | Marcador sorológico de infecção aguda    |
| IgG anti-HEV | Marcador de infecção passada e imunidade |

#### Quadro 175.7 | Avaliação dos marcadores sorológicos da hepatite C

|          |                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-HCV | Indica contato prévio com o vírus da hepatite C, porém, não define se a infecção é aguda ou pregressa e curada espontaneamente, ou se houve cronificação da doença |
| HCV-RNA  | Indica infecciosidade presente. Possibilita a genotipagem viral – existem seis genótipos. Auxilia na escolha terapêutica                                           |

#### Quadro 175.8 | Avaliação dos marcadores sorológicos da hepatite D

|              |                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDVAg        | Marcador sorológico de infecção aguda precoce. Presente em 26% na coinfeção aguda HBV1-HDV. Marcador de tecido hepático: fase aguda, fulminante e crônica |
| IgM anti-HDV | Marcador de infecção aguda e infecção ativa persistente                                                                                                   |
| IgG anti-HDV | Marcador de infecção passada e imunidade. É um anticorpo estável                                                                                          |
| HDV-RNA      | Expressão intra-hepática do HDVAg, marcador de replicação na fase aguda ou crônica                                                                        |



**Quadro 175.5 | Avaliação dos marcadores sorológicos da hepatite B aguda**

|                |                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HBsAg          | É o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV, declinando a níveis indetectáveis em 6 meses na doença aguda e correspondendo ao antígeno de superfície viral                |
| Anti-HBc-IgM   | É marcador de infecção recente, encontrado no soro até 8 meses após a infecção                                                                                                                |
| Anti-HBc total | É marcador presente nas infecções agudas pela presença de IgM e crônicas pela presença de IgG. Representa contato prévio com o vírus                                                          |
| HBeAg          | É marcador de replicação viral; sua positividade indica alta infecciosidade e corresponde ao antígeno do <i>core</i> viral                                                                    |
| Anti-HBe       | Surge após o desaparecimento do HBeAg, indicando o fim da fase replicativa. Convalescença                                                                                                     |
| HBV-DNA        | É indicativo de infecção presente                                                                                                                                                             |
| Anti-HBs       | É o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas |

**Quadro 175.6 | Avaliação dos marcadores sorológicos da hepatite B crônica**

|          |                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HBsAg    | Sua presença por mais de 6 meses é indicativa de hepatite crônica                                                                           |
| HBeAg    | Na infecção aguda ou crônica, está presente enquanto ocorrer alta replicação viral                                                          |
| Anti-HBe | Sua presença sugere redução ou ausência de replicação viral, exceto nas cepas com mutação pré- <i>core</i> (não produtoras da proteína “e”) |



# TRATAMENTO

- A abordagem prática das hepatites agudas de origem viral deve basear-se, em princípio, em medidas de suporte, não havendo medicação específica para as formas agudas.
- O prognóstico é muito bom nas hepatites A e E, sendo a sua evolução para cura clínica e microbiológica.
- A resolução espontânea da hepatite pelo vírus B ocorre em 90 a 95% dos casos em adultos jovens previamente saudáveis, o que dispensa terapêutica medicamentosa antiviral.



- O uso de fármacos com potencial hepatotóxico, como paracetamol, deve ser evitado, e, em caso de absoluta contraindicação de outros analgésicos e/ou antitérmicos, deve-se observar a dose máxima diária recomendada, 4 gramas ao dia.
- A administração de corticosteroide está formalmente contraindicada.
- O consumo de álcool deve ser abolido completamente durante a doença aguda e por um período de pelo menos seis meses após a alta.
- O tratamento medicamentoso está indicado para algumas formas da doença crônica e, em razão de sua complexidade, deverá ser realizado em ambulatório especializado.

- A indicação de tratamento baseia-se no grau de acometimento hepático observado e, também, nas variáveis apresentadas a seguir (indicações para tratamento da hepatite B):

- ❑ Apresentar HBsAg positivo por mais de 6 meses.
- ❑ Apresentar HBeAg positivo ou HBV-DNA  $> 10^4$  cópias/mL ou 2.000 UI/mL (fase de replicação).
- ❑ Apresentar ALT/TGO maior que duas vezes o limite superior da normalidade.
- ❑ A biópsia hepática vem sendo considerada opcional na maioria dos consensos, podendo até ser dispensada nos casos com ALT elevada e HBV-DNA elevado que preencham claramente os critérios de tratamento.

**Tabela 175.2 | Esquemas terapêuticos para tratamento da hepatite B crônica**

| <b>Fármaco</b>          | <b>Dose</b>                                                                 | <b>Via</b> | <b>Duração</b>                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Interferon convencional | 5 milhões de unidades diariamente, ou 10 milhões de unidades 3 vezes/semana | SC         | 16 semanas                     |
| Lamivudina              | 100 mg, uma vez por dia                                                     | VO         | 48 semanas                     |
| Tenofovir               | 300 mg, uma vez ao dia                                                      | VO         | Depende da soroconversão       |
| Entecavir               | 0,5-1,0 mg, uma vez ao dia                                                  | VO         | Depende da clínica do paciente |

- Há consenso quanto ao tratamento convencional da hepatite C nas pessoas com idade a partir de 18 anos com HCV-RNA positivo e fibrose hepática significativa.
- Considera-se o tratamento se o indivíduo está motivado e preparado para uma boa adesão ao regime.
- São critérios de exclusão ao tratamento:
  - ❑ Idade avançada;
  - ❑ Descompensação hepática;
  - ❑ Plaquetopenia < 70.000/Ml;
  - ❑ Ascite de difícil controle;
  - ❑ Encefalopatia ;
  - ❑ Neutrófilos < 1.500 mm<sup>3</sup>.

**Tabela 175.3 | Novos esquemas terapêuticos (daa) da hepatite C crônica**

| <b>Medicação</b> | <b>Classe terapêutica</b>                 | <b>Atua nos genótipos</b> | <b>Associações</b>      | <b>Duração/dose</b>                           |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Daclatasvir      | Inibidor NS5A                             | 1, 2, 3, 4                | Sofosbuvir ± Ribavirina | 12-24 semanas<br>30, 60 ou 90 mg<br>1x ao dia |
| Simeprevir       | IP do HCV                                 | 1 e 4                     | Sofosbuvir ± Ribavirina | 12-24 semanas<br>150 mg 1x ao dia             |
| Sofosbuvir       | Inibidor de polimerase nucleotídeo do HCV | Todos                     |                         |                                               |

O Sistema Único de Saúde, desde 2015, incorporou as três medicações ao tratamento da hepatite C (daclatasvir, simeprevir e sofosbuvir); aumentaram em 90% a chance de cura e com menos efeitos colaterais

# ACOMPANHAMENTO

- As consultas devem ser realizadas quinzenalmente no início da doença.
- Consultas posteriores devem ser programadas conforme a evolução da doença.
- Os exames solicitados nas consultas de acompanhamento são hemograma completo, TGO e TGP, bilirrubina total/direta (BT/BD) e gamaglutamiltransferase (GGT).
- O critério para alta dos doentes deve incluir remissão dos sintomas e normalização das bilirrubinas e aminotransferases.
  - ❑ Duas dosagens normais em um intervalo de 4 semanas.

# POLÍTICAS PÚBLICAS

- O Programa Nacional de Hepatites Virais, criado em fevereiro de 2002, tem como objetivos:
  - ❑ Desenvolver as ações de promoção da saúde, prevenção e assistência aos pacientes com hepatites virais,
  - ❑ Reforçar a vigilância epidemiológica e sanitária,
  - ❑ Ampliar o acesso e incrementar a qualidade e a capacidade instalada dos serviços de saúde em todos os seus níveis de complexidade,
  - ❑ Organizar, regulamentar, acompanhar e avaliar o conjunto das ações de saúde na área de Hepatites.
- Realização de testagem sorológica + aconselhamento + reforçar vacinação.
- O Ministério da Saúde disponibiliza, na atenção primária, testes rápidos para detecção das Hepatites B e C.



# DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE



## COMO SE PREVENIR DAS HEPATITES VIRAIS?



**Lave bem as mãos** antes das refeições e após usar o banheiro.



**Lave e cozinhe bem os alimentos** antes de consumi-los.



Não tome banho em **riachos perto de esgoto aberto**.



**Vaccine-se.**



**Use preservativos** em todas as relações sexuais.



**Não compartilhe objetos de uso pessoal**, como barbeadores e alicates de unha.



Não compartilhe **nenhum objeto que possa ter tido contato com sangue**, como seringas e agulhas.

**JULHO  
AMARELO**

A luta contra as  
hepatites virais  
começa com a  
conscientização.

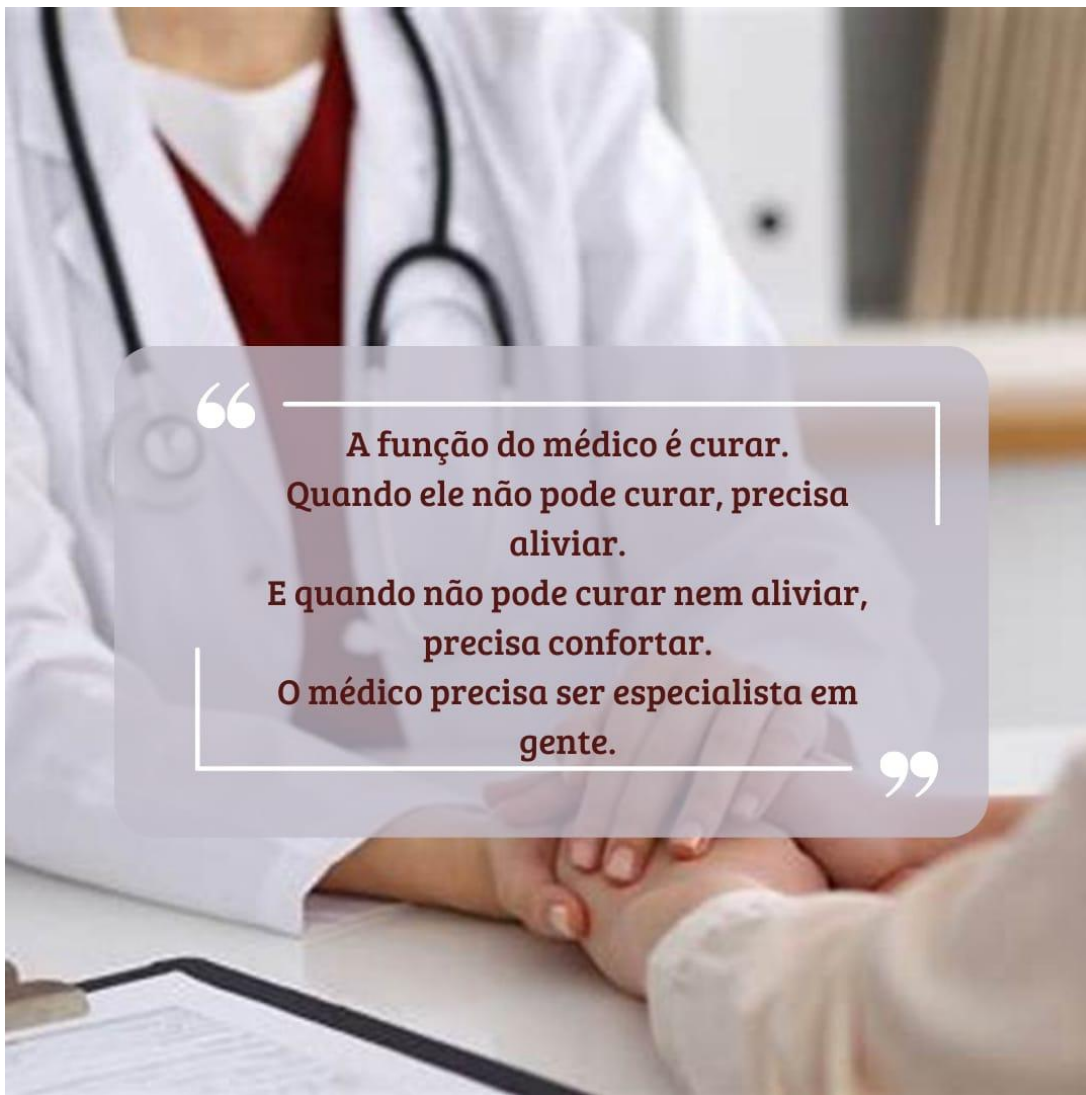


**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Saúde*

## Referências Bibliográficas:

GUSSO, G, et al. Tratado de medicina de família e comunidade - 2 volumes: princípios, formação e prática. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2019. Cap. 175. Hepatites.

DUNCAN, B, B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. (Cap. 142)



“

A função do médico é curar.  
Quando ele não pode curar, precisa  
aliviar.

E quando não pode curar nem aliviar,  
precisa confortar.

O médico precisa ser especialista em  
gente.

”

Obrigada!